PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

Here for You

PANDUAN PERAWATAN PASIEN ISOLASI

RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

TABEL KONTROL DOKUMEN

PANDUAN PERAWATAN PASIEN ISOLASI RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA					
Status Dokumen	**Status Review**	**Status Revisi**	**Tanggal Terbit**	**Tanggal Efektif**	**Tanggal Peninjauan Kembali**
Baru	00	00	01 Agustus 2022	01 September 2022	01 Agustus 2025
Revisi	01	01	01 Agustus 2025	01 September 2025	01 Agustus 2028

RIWAYAT REVISI

Revisi	Penanggung Jawab	No Dokumen	Uraian Perubahan
00	Komite PPI	077/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/VIII/2022	- Baru
01	Komite PPI	045/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/VIII/2025	- Perubahan Tata Naskah - Isi Konten - Layout konten

Cara Pengisian :

1. **Judul Dokumen**

   Diisi sesuai dengan judul dokumen yang ditetapkan.

2. **Status Dokumen**

   Diisi sesuai status dokumen, yaitu Baru atau Revisi.

3. **Status Review dan Status Revisi**

   Diisi menggunakan dua digit angka (00, 01, 02, dan seterusnya) sesuai dengan jumlah review dan/atau revisi yang telah dilakukan terhadap dokumen.

CONTROLLED

4. **Tanggal Terbit**

   Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya dokumen oleh pejabat yang berwenang.

5. **Tanggal Efektif**

   Diisi 1 (satu) bulan setelah tanggal terbit.

6. **Tanggal Peninjauan Kembali**

   Diisi 3 (tiga) tahun setelah tanggal terbit, atau menyesuaikan dengan kebijakan peninjauan regulasi yang berlaku.

7. **Nomor Dokumen**

   Diisi sesuai dengan ketentuan penomoran regulasi Rumah Sakit Primaya.

8. **Uraian Perubahan**

   Diisi dengan penjelasan singkat mengenai perubahan yang dilakukan, baik penambahan, pengurangan, maupun perbaikan isi dokumen.

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA

NOMOR : 045/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/VIII/2025

TENTANG

PANDUAN PERAWATAN PASIEN ISOLASI

RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA

Menimbang :

a. bahwa penularan airborne adalah penularan mikroorganisme yang melalui penyebaran partikel kecil ke udara baik secara langsung atau melalui partikel debu yang mengandung mikroorganisme infeksius. bahwa
b. pengelolaan udara dan ventilasi secara khusus diperlukan untuk mencegah transmisi penyakit melalui udara.
c. bahwa kewaspadaan berbasis transmisi harus dilaksanakan sebagai tambahan dari kewaspadaan standar apabila merawat pasien yang menular secara airborne.
d. bahwa diperlukan suatu panduan untuk memastikan dilaksanakannya pencegahan transmisi arborne dengan ditetapkannya suatu Peraturan Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di

CONTROLLED

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).
6. Panduan Teknis Pelayan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA TENTANG PANDUAN PERAWATAN PASIEN ISOLASI RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA.

Kedua : Memberlakukan PANDUAN PERAWATAN PASIEN ISOLASI DI RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA terlampir dalam Keputusan ini.

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

(dr. Agus Marvianto)

CONTROLLED

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga buku Panduan Perawatan Pasien Isolasi di Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara dapat disusun dan diselesaikan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di lain pihak Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara juga dihadapkan pada tantangan yang semakin besar, yaitu tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabel, dan transparan kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin keselamatan pasien (patient safety).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara perlu terus meningkatkan mutu pelayanan, khususnya dalam perawatan pasien isolasi. Buku Panduan Perawatan Pasien Isolasi ini menguraikan pedoman pelaksanaan perawatan pasien isolasi di Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit, baik bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga pasien, maupun lingkungan rumah sakit.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan panduan ini di masa yang akan datang.

Pangkalpinang, 02 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

dr. Agus Marvianto

CONTROLLED

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN DIREKTUR **4**

KATA PENGANTAR **6**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I DEFINISI **1**

BAB II RUANG LINGKUP **2**

BAB III TATA LAKSANA **4**

A. Prinsip Isolasi 4

B. Prinsip Kamar Isolasi/Single Room 4

C. Penempatan Pasien 5

D. Manajemen saat pasien sudah diisolasi 6

E. Memasuki dan meninggalkan Kamar Isolasi 7

F. Pemindahan Pasien yang Dirawat di Ruang Isolasi 8

G. Tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk kasus isolasi 8

H. Prinsip Pencegahan Penularan Infeksi 9

I. Kewaspadaan Standar (Standar Precautions) 10

J. Penatalaksanaan perawatan pasien isolasi di ruangan: 13

K. Kewaspadaan berdasarkan penularan/transmisi *(Transmission-based Precautions)* 16

L. Kewaspadaan penularan melalui percikan (droplet) 18

M. Pemulangan Pasien 21

N. Perawatan Kasus Meninggal untuk Pasien SARS (Flu Burung, Flu Babi (Emerging Case), Influenza A, MERS-CoV, Covid-19, ISPA lain yang berpotensi mejadi wabah. 22

O. Pembersihan Peralatan dan kamar Pasien 22

CONTROLLED

P. Outbreaks/ Kejadian luar biasa 23

Q. Keselamatan Kerja 23

BAB V DOKUMENTASI..... 32

CONTROLLED

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA
NOMOR : 045/PER/DIR/PT.FMP-PHBW/VIII/2025
TENTANG KEBIJAKAN PANDUAN PERAWATAN PASIEN ISOLASI
RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA

PANDUAN
PERAWATAN PASIEN ISOLASI
RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA

BAB I
DEFINISI

Ruang isolasi adalah ruangan khusus yang terdapat di rumah sakit yang merawat pasien dengan kondisi medis tertentu terpisah dari pasien lain ketika mereka mendapatkan perawatan medis dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit atau infeksi kepada pasien dan mengurangi resiko terhadap pemberi layanan kesehatan. Isolasi menggambarkan pemisahan pasien yang terinfeksi selama masa inkubasi dengan kondisi tertentu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penularan baik langsung maupun tidak langsung dari orang yang rentan.

Ruang isolasi bertekanan negatif di Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara diperuntukan untuk pasien penderita penyakit menular sesuai dengan indikasi yang sudah ditetapkan.

CONTROLLED

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang Isolasi yang bertekanan negatif adalah:

1. Ruangan perawatan dengan satu atau dua bed (pasien terpisah dengan pasien lain)
2. Minimal pergantian udara 6 – 12 x/jam
3. Memiliki ruang antara (*ante room*)
4. Memiliki fasilitas yang tersendiri, terpisah dari fasilitas ruangan/ pasien lain

Indikasi perawatan isolasi:

1. Semua pasien dengan TB Paru kecuali pada pasien anak atau pasien dewasa dengan:
   - BTA positif (+) yang sudah mendapatkan terapi selama 2 minggu
   - BTA negatif (-) dengan lesi luas dan sudah mendapatkan terapi selama 2 minggu
2. TB ekstra paru yang berat dan dari klinis yang mendukung
3. Pasien partus/ inpartu dengan BTA (+) / TB (+)
4. Pasien dengan Varicella
5. Pasien dengan Morbili/ Campak
6. Pasien MUMPS/ Parotitis
7. Pasien Pertusis
8. Pasien Herpes Zoster
9. Pasien SARS, (Flu Burung/avian influenza, Flu Babi, MERS Cov, dan ISPA lain berpotensi menjadi wabah) sesuai ketentuan Dinkes setempat (dirujuk)
10. Covid-19

Pasien dengan indikasi tersebut di atas harus dirawat ke dalam ruangan isolasi bertekanan negatif.

Ruang isolasi bertekanan *negative* tersedia di:

1. Lantai 1 Isolasi IGD
2. Lantai 1 Ruang Isolasi Unit St. Yosef

CONTROLLED

Jika ruang isolasi tekanan negatif tersebut diatas tidak tersedia atau penuh maka pasien dapat dirawat di:

1. Ruangan perawatan tersendiri yaitu Ruang St. Teresia
2. Ruangan perawatan biasa bergabung dengan pasien yang terdiagnosa penyakit sejenis dengan jarak antar bed > 1 meter (minimal jarak 1,5 meter/ 2,4 meter) sampai dengan ruangan isolasi tersedia (*Cohorting*).
3. Tata laksana perawatan di ruangan tersebut diatas, mengikuti/ sama dengan tata laksana ruang isolasi bertekanan negatif.

Jika ruang perawatan dengan kriteria diatas tidak tersedia maka pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Bilamana terjadi lonjakan pasien yang membutuhkan ruang isolasi tekanan negatif yang emerging disease namun ruang perawatan dengan kriteria tidak tersedia, maka dibuat *Temporary Negatif Pressure Isolation.*

CONTROLLED

BAB III
TATA LAKSANA

Isolasi di Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara mengacu kepada penggunaan dari *singleroom* sebagai *barrier* untuk mencegah transmisi dari organisme penyebab infeksi. Pemakaian alat pelindung diri juga sangat penting untuk mencegah infeksi silang dan berkontribusi sebagai *barrier precautions*. Ketika pasien diduga atau pasti mengalami infeksi, sangat penting untuk mengetahui mode transmisi infeksinya dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah infeksi.

A. Prinsip Isolasi

Adalah mengenai saat yang tepat dalam menempatkan pasien dengan penyakit menular (atau diduga menderita penyakit menular) ke *single room* yang bisa sangat efektif mereduksi risiko transmisi penyakit ke pasien lain. *Isolation Precautions* atau *Standar Precautions* harus diterapkan setiap saat pada seluruh pasien termasuk pasien isolasi. Infeksi bisa ditransmisikan dalam cara yang berbeda dan inti dari isolasi adalah meminimalisasi risiko tersebut ke pasien. Semua petugas harus mengerti bagaimana organisme menyebar agar dapat menerapkan prosedur isolasi yang tepat pada pasien. Risiko infeksi harus dikaji sebagai bagian pengkajian klinis pasien.

B. Prinsip Kamar Isolasi/Single Room

Single room diperlukan ketika kehadiran pasien menjadi risiko penyebab infeksi ke pasien lainnya (sumber isolasi) atau pasien berisiko terkena infeksi dari yang lainnya (proteksi isolasi). Ketika isolasi dilakukan pada pasien, keuntungan dan kerugian harus dipertimbangkan sehubungan dengan efek psikologi pada pasien. Untuk mengurangirisiko tersebut, edukasi dan informasi harus diberikan agar pasien dapat kooperatif.

CONTROLLED

C. Penempatan Pasien

Keputusan untuk mengisolasi pasien harus berdasarkan, risiko infeksi, tanda dan gejala, dan risiko transmisi penyakit. Bentuk isolasi yang paling efektif adalah penggunaan *single room*. Ketika ada *single room* yang *available* di rumah sakit, hal ini menjadi prioritas utama pasien ditempatkan.

1. Indikasi penempatan pasien dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan(DPJP). Pengawasan terhadap pasien dilakukan oleh perawat khusus sesuai dengan terhadap Kewaspadaan Standar di ruang isolasi.
2. Ruang isolasi diperuntukkan untuk pasien:
   a) Diketahui atau dicurigai ditularkan melalui kontak, antara lain pasien dengan scabies, herpes simpleks, MRSA dan Covid-19.
   b) Diketahui atau dicurigai ditularkan melalui *Airborne*, seperti penyakit TBC dengan terapi kurang dari 2 minggu, varicella, morbili, Mumps/ parotitis, pertusis, Herpes zoster, SARS (Flu Burung, Flu Babi, Influenza MERS, Covid-19 yang menghasilkan aerosol).
   c) Diketahui atau dicurigai ditularkan melalui droplet pernapasan yang dikeluarkan selama berbicara, batuk atau bersin seperti common cold, respiratory syncitial virus (RSV), Adenovirus, H5N1, H1N1, Covid-19.
3. Ruang isolasi penyakit menular melalui droplet dan *airborne*:

   Letakkan pasien di dalam satu ruangan tersendiri. Jika ruangan tersendiri tidak tersedia, kelompokkan kasus yang telah dikonfirmasi secara terpisah di dalam ruangan atau bangsal dengan beberapa tempat tidur dari kasus yang belum dikonfirmasi atau sedang didiagnosis. Bila ditempatkan dalam 1 ruangan, jarak antar tempat tidur harus lebih dari 1 m, bila memungkinkan 1,8 meter dan diantara tempat tidur harus ditempatkan penghalang fisik seperti tirai atau sekat.

   Untuk jarak tempat tidur pasien terkonfirmasi covid-19 adalah minimal 1,5- 1,8 meter / 2,4 meter
4. Jika memungkinkan, upayakan ruangan tersebut dialiri udara bertekanan negatif yang dimonitor (ruangan bertekanan negatif) dengan 6-12 pergantian udara per jam dan sistem pembuangan udara

CONTROLLED

keluar atau menggunakan saringan udara partikulasi efisiensi tinggi (filter HEPA) yang termonitor sebelum masuk ke sistem sirkulasi udara lain di rumah sakit.

5. Jika tidak tersedia ruangan bertekanan negatif dengan sistem penyaringan udara partikulasi efisiensi tinggi, buat tekanan negatif di dalam ruangan pasien dengan memasang pendingin ruangan atau kipas angin di jendela sedemikian rupa agar aliran udara ke luar gedung melalui jendela. Jendela harus membuka keluar dan tidak mengarah ke daerah publik. Uji untuk tekanan negatif dapat dilakukan dengan menempatkan sedikit bedak tabur / tissue di bawah pintu dan amati apakah terhisap kedalam ruangan. Jika diperlukan kipas angin tambahan di dalam ruangan dapat meningkatkan aliran udara.
6. Jaga pintu tertutup setiap saat dan jelaskan kepada pasien mengenai perlunya tindakanpencegahan ini.
7. Pastikan setiap orang yang memasuki ruangan memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai yaitu masker bedah, bila melakukan tindakan aerosol, gunakan masker Respirator yaitu masker N95;
8. Pakai sarung tangan bersih atau pemeriksaan (non steril) ketika masuk ruangan.
9. Pakai gaun yang bersih ketika masuk ruangan jika akan berhubungan dengan pasien atau kontak dengan permukaan atau barang-barang di dalam ruangan.

D. Manajemen saat pasien sudah diisolasi

Prinsip dasar yang diterapkan untuk meminimalisasi risiko transmisi silang infeksi:

1. Perawat dan petugas lain yang memasuki kamar isolasi di batasi.
2. Pengunjung dan penunggu pasien dibatasi dan tidak perlu memakai apron plastik atau sarung tangan saat mengunjungi pasien. Pada masa covid-19 pengunjung ditiadakan.
3. Pintu kamar isolasi harus selalu dalam keadaan tertutup dan pasien diedukasi agar selalu tetap di dalam kamar
4. Ruangan isolasi harus selalu dalam keadaan bersih. Pembersihan rutin minimal 2 kalisehari dan di akhir masa perawatan dilakukan

CONTROLLED

general cleaning.

5. Peralatan medis untuk pasien isolasi seperti tensi meter, pengukur suhu khusus tidak dicampur dengan pasien lain sampai dengan pasien tersebut pulang atau tidak membutuhkan ruang isolasi kembali.
6. Fasilitas mencuci tangan dan alat pelindung diri bagi petugas diletakan di ruang antara.
7. Diusahakan agar petugas yang merawat pasien dengan infeksi menular tidak merawat pasien dengan imunokompromise.
8. Petugas yang merawat pasien dengan infeksi menular membatasi kontak dengan petugas yang merawat pasien dengan imunokompromise.
9. Pasien wajib menggunakan masker selama perawatan di Rumah Sakit selama kondisi pandemi Covid-19.

E. Memasuki dan meninggalkan Kamar Isolasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perawatan pasien di ruang isolasi :

1. Saat memasuki ruang isolasi:
   a) Semua peralatan yang dibutuhkan sudah disiapkan sebelumnya.
   b) Lakukan kebersihan tangan dengan air mengalir atau menggunakan handrub berbasis alkohol.
   c) Memakai Alat Pelindung Diri (APD).
2. Saat meninggalkan ruang isolasi:
   d) APD dilepaskan pada ruang antara.
   e) Lakukan kebersihan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan handrub berbasis alkohol.
   f) Masker dilepaskan dengan memegang elastik di belakang telinga dan jangan menyentuh bagian depan masker.
   g) Setelah di luar ruangan, kembali lakukan kebersihan tangan dengan air mengalir atau menggunakan handrub berbasis alkohol.

CONTROLLED

F. Pemindahan Pasien yang Dirawat di Ruang Isolasi

1. Pergerakan dan trasportasi pasien dari ruangan isolasi hanya untuk keperluan penting.
2. Pada saat melakukan transfer pasien, pasien diharapkan menggunakan masker bedah (untuk pasien dengan penularan droplet dan *airborne*).
3. Apabila pasien akan di bawa ke luar ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan maka petugas memberi tahu tempat yang akan menerima sesegera mungkin sebelum pasien tiba dan pada saat transportasi terjadi pasien memakai masker.
4. Semua petugas yang terlibat dalam transportasi pasien harus menggunakan APD yang sesuai. Demikian pula jika pasien perlu dipindahkan keluar dari Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara.
5. Semua permukaan yang kontak dengan pasien harus dibersihkan.
6. Untuk pasien yang dipindahkan menggunakan ambulance, maka sesudahnya ambulance tersebut dipakai harus dibersihkan dengan cairan yang mengandung Chlorin 0.5%

G. Tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk kasus isolasi

Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi dirancang untuk memutus siklus penularan penyakit dan melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat. Pada tahun 1996, CDC merevisi petunjuk isolasi untuk rumah sakit (*Isolation Precautions*) dan terdiri dari dua komponen:

1. *Standar Precautions* untuk semua pasien. Ini mirip dengan *Universal Precautions*, tapi sarung tangan dipakai untuk seluruh daerah lembab pada pasien, termasuk ekskresi dan sekresi. Bertujuan untuk mengurangi risiko penularan mikroorganisme di rumah sakit, baik dari sumber infeksi yang diketahui maupun yang tidak diketahui dalam sistem pelayanan kesehatan seperti pasien, benda tercemar, jarum atau spuit yang telah digunakan. Kewaspadaan standar diterapkan untuk sekreta pernafasan, darah, dan semua cairan tubuh lainnya serta semua ekskreta (kecuali

CONTROLLED

keringat), kulit yang tidak utuh dan membran mukosa. Prinsip ini diterapkan pada semua petugas kesehatan dan pasien/orang yang datang ke rumah sakit Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara

2. *Transmission-based Precautions* (kewaspadaan berdasarkan cara penularan) untuk pasien yang terdiagnosa atau dicurigai infeksi yang dapat ditularkan melalui udara, cairan atau kontak, atau terinfeksi atau terkolonisasi dengan organism yang epidermis.
   a) *Airborne Precautions* digunakan untuk infeksi yang disebar oleh cairan yang butirannya lebih kecil dari 5 μm.
   b) Droplet *Precautions* digunakan untuk infeksi yang disebarkan melalui butiran cairan yang lebih besar (> 5 μm).
   c) Contact *Precautions* dipakai untuk pasien yang diketahui atau dicurigai terinfeksidengan organism epidermis.

H. Prinsip Pencegahan Penularan Infeksi

Pencegahan penyebaran infeksi memerlukan dihilangkannya satu atau lebih kondisi yang diperlukan bagi pejamu atau **reservoir** untuk menularkan penyakit ke pejamu rentan lainnya dengan cara:

1. Menghambat atau membunuh agen (bakteri, virus, jamur, parasit) dengan mengaplikasikan antiseptik ke kulit sebelum tindakan atau pembedahan.
2. Memblokir cara agen berpindah dari orang yang terinfeksi ke orang lain yang rentan misalnya dengan mencuci tangan atau memakai antiseptik handrub untuk membersihkan bakteri atau virus yang didapat pada saat bersentuhan dengan pasien terinfeksi atau permukaan tercemar.
3. Mengupayakan petugas kesehatan untuk diimunisasi atau divaksinasi.
4. Petugas memakai APD yang memadai untuk mencegah kontak dengan agen infeksi, misalnya sarung tangan rumah tangga untuk petugas kebersihan dan petugas pembuangan sampah rumah sakit.

CONTROLLED

I. Kewaspadaan Standar (Standar Precautions)

Kewaspadaan standar yang diterapkan di rumah sakit Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara meliputi:

1. Kebersihan tangan

   Melakukan kebersihan tangan sesuai standar prosedur. Tindakan yang paling mudah dan dapat mencegah pencemaran silang dari orang ke orang atau dari obyek yang tercemar ke orang. Tindakan membersihkan tangan harus dilakukan pada keadaan:

   a. Sebelum kontak dengan pasien
   b. Sebelum tindakan aseptik
   c. Setelah terkena cairan tubuh pasien
   d. Setelah kontak dengan pasien
   e. Setelah kontak dengan lingkungan pasien

   Kadang-kadang diperlukan mencuci tangan diantara dua tugas atau prosedur yang berbeda pada pasien yang sama untuk mencegah kontaminasi silang pada bagian tubuh yang lain.

   Gunakan sabun biasa untuk prosedur kebersihan tangan rutin dan antiseptik berbasis alkohol digunakan jika tangan tidak tampak kotor. Cairan antiseptik untuk cuci tangan seperti chlorhexidine digunakan pada saat outbreak (Kejadian Luar Biasa) dan sebelum melakukan tindakan invasif. Cairan antispetik berbasis alkohol digunakan untuk membersihkan kulit atau membran mukosa sebelum pembedahan, membersihkan luka, serta melakukan penggosokkan tangan *surgical handsrub.*

2. Menggunakan alat perlindungan diri:

   a. Sarung tangan pemeriksaan/bersih (non steril):

      1) Sarung tangan tidak menggantikan kebutuhan untuk membersihkan tangan, karena sarung tangan mungkin ada pori kecil yang tidak terlihat atau sobek selama penggunaan atau tangan dapat terkontaminasi pada saat melepaskan sarung tangan.
      2) Harus mengganti sarung tangan setelah kontak dengan

CONTROLLED

pasien untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi.

3) Petugas kesehatan harus melepas sarung tangan sebelum meninggalkan ruangan pasien dan segera mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handrub berbasis alkohol.
4) Pakai sarung tangan (bersih dan tidak perlu steril) bila menyentuh darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, dan barang-barang terkontaminasi. Pakai sarung tangan tepat sebelum menyentuh lapisan mukosa dan kulit yang luka (*non-intact skin*). Ganti sarung tangan diantara dua tugas dan prosedur berbeda pada pasien yang sama setelah menyentuh bagian yang kemungkinan mengandung banyak mikroorganisme. Lepas sarung tangan tepat saat selesai tugas, sebelum menyentuh barang dan permukaan lingkungan yang tidak terkontaminasi, dan sebelum berpindah ke pasien lain, dan cuci tangan segera untuk mencegah perpindahan mikroorganisme ke pasien lain atau lingkungan.

b. Masker, Pelindung Mata, Pelindung Wajah

5) Gunakan masker bedah dan pelindung mata atau wajah untuk melindungi lapisan mukosa pada mata, hidung dan mulut saat melakukan prosedut atau aktifitas perawatan pasien yang memungkinkan adanya cipratan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi. Prosedur atau tindakan yang dapat menimbulkan aerosol adalah:
   a) Tindakan yang dapat menimbulkan batuk akan meningkatkan pengeluaran *droplet nuclei* ke udara.
   b) Tindakan yang menghasilkan aerosol seperti tindakan pengobatan yang diaerosolisasi (misalnya salbutamol), induksi sputum diagnostic, bronkoskopi, pengisapan jalan napas dan intubasi endotrakeal.
6) Setiap orang yang berhubungan langsung, berada dekat dengan pasien atau memasuki suatu ruangan dimana ada

CONTROLLED

pasien dengan penyakit menular harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai. Untuk pasien dengan penyakit menular melalui *Airborne*, petugas wajib gunakan master N95, menggunakan gaun, pelindung wajah atau pelindung mata dan sarung tangan.

7) Masker Respirator (N95) dapat digunakan beberapa kali jika digunakan oleh orang yang sama. Jika respirator khusus tidak tersedia, petugas harus menggunakan masker bedah yang dapat melekat erat menutup hidung dan mulut dengan rapat.
8) Pada kondisi pandemi Covid-19, diluar tindakan aerosol atau memberikan pelayanan kepada pasien yang penularan dari Airborne, maka masker bedah tetap selalu digunakan.

c. Gaun Pelindung

Gunakan gaun (bersih dan tidak perlu steril) untuk mengurangi kemungkinan penyebaran mikroorganisme di dalam rumah sakit, melindungi kulit dan mencegah kontaminasi/ternodanya pakaian saat melakukan prosedur dan aktifitas perawatan pasien yang memungkinkan adanya cipratan darah, banyak tidaknya jumlah cipratan cairan yang kira-kira ada. Lepas gaun kotor sesegera mungkin dan cuci tangan untuk mencegah perpindahan mikroorganismeke pasien lain atau lingkungan. Gaun terbuat dari bahan kedap air.

d. Penutup kaki atau sepatu harus tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap kulit bila ada kemungkinan terjadi tumpahan atau percikan bahan infeksius dalam jumlah besar.

10. Peralatan Perawatan pasien

Peralatan perawatan pasien yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi hendaknya diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhan dengan kulit dan lapisan mukosa, tidak mengotori pakaian, dan tidak memindahkan mikroorganisme ke pasien lain dan lingkungan. Pastikan bahwa peralatan yang dapat dipakai ulang tidak dipakai lagi untuk pasien

CONTROLLED

lain sebelum dibersihkan dan ditangani dengan benar sesuai prosedur tetap. Peralatan bekas pakai langsung diantar ke CSSD yang nantinya akan dilakukan dekontaminasi di CSSD

J. Penatalaksanaan perawatan pasien isolasi di ruangan:

1) Petugas kesehatan
   a) Kewaspadaan standar wajib diterapkan.
   b) Wajib memakai dan melepas Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tindakanyang akan dilakukan di ruang antara.
   c) Menutup pintu setiap kali masuk dan keluar ruangan.
   d) Staf yang merawat pasien tidak dalam risiko menularkan penyakit (demam, flu,batuk, ISPA).
   e) Edukasi kepada keluarga untuk memakai APD selama di dalam ruangan.
   f) Edukasi kebersihan tangan kepada keluarga sebelum dan sesudah dari ruangan.
   g) Edukasi kepada pasien etika berbicara, batuk dan bersin.
   h) Memisahkan linen habis pakai dan diberi label infeksius.
   i) Pisahkan fasilitas atau alat kesehatan dari pasien yang lain.
   j) Petugas yang merawat pasien adalah perawat yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan sudah mendapatkan pelatihan pengelolaan ruangan isolasi dan hasil kesehatan baik dan telah mendapatkan pelatihan PPI Dasar.
   k) Dilakukan *medical check up* sesuai dengan ketentuan rumah sakit setiap tahun.

2) Keluarga pasien/ pengunjung
   a) Wajib melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah dari ruangan.
   b) Memakai dan melepas Alat Pelindung Diri (APD) masker di ruang antara.
   c) Batasi pengunjung, terutama pengunjung dengan risiko imun rendah (anak-anak, orang tua, pasien dengan imunocompromised) & pengunjung risiko menularkan penyakit

CONTROLLED

(varicella, campak, demam, dan ISPA).

d) Selama kondisi covid-19 penungjung ditiadakan.

3) Pasien

a) Pembatasan mobilisasi, bicara.

b) Wajib memakai APD masker bila keluar dari ruangan misalnya ke ruangRadiologi, HD, Fisioterapi dan lain-lain.

c) Selama pandemi covid-19, pasien wajib menggunakan masker selama perawatandan saat transfer

4) Alur Pasien

Pasien yang dirawat di ruang intensive, alur masuk & keluar pasien dan keluarga dibedakan waktunya dari pasien non infeksi.

5) Kebersihan lingkungan

Ruangan isolasi Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara dibersihkan dan didesinfeksi setiap hari, minimal dua kali sehari atau bilamana perlu meliputi seluruh permukaan, seperti meja, kaki tempat tidur dan lantai dengan menggunakan cairan yang mengandung Clorin 0.5% sebagai desinfektan, contoh tempat tidur, meja pasien, tiang infus, monitor, Remote TV/AC, bel dan semua barang atau benda yang tersentuh sesuai dengan prosedur.

6) Penanganan linen

Linen kotor ditangani dengan hati-hati dan cermat sesuai prosedur tetap supaya jangan sampai terkena kulit atau membran mukosa. Linen kotor dibagi dua yaitu linen kotor infeksius (linen kotor yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh dan linen yang berasal dari pasien yang menular lewat kontak) dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning dan linen kotor non infeksius (linen kotor yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh) dimasukkan dalam kantong plastik putih. Segera mengganti linen

CONTROLLED

yang tercemar/terkena darah atau percikan cairan tubuh. Tidak merendam dan/atau membilas linen kotor di wilayah ruang perawatan. Tidak meletakkan linen kotor di lantai dan mengibaskan linen kotor. Selanjutnya linen kotor dikirim ke unit pencucian dan ditangani sebagai linen terkontaminasi.

7) Pembuangan Sampah dan Benda Tajam

Buang sampah sesuai ketentuan yang berlaku untuk sampah infeksius (semua sampah hasil kegiatan perawatan dan pengobatan pasien yang kontak langsung dengan tubuh pasien atau cairan tubuh pasien ke kantong plastik kuning dan sampah non infeksius (limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman) ke kantong plastik hitam. Jangan menutup kembali jarum yang sudah digunakan, bila terpaksa lakukan dengan teknik satu tangan. Jangan melepas jarum yang telah digunakan dari spuit sekali pakai. Jangan membengkokkan, menghancurkan atau memanipulasi jarumdengan tangan. Masukkan instrumen tajam ke dalam wadah yang tahan tusukan dan tahan air (wadah penampung khusus).

8) Kesehatan karyawan dan *Bloodborne Pathogens* (Penularan Penyakit Melalui Darah) Jangan sampai terluka saat memakai jarum, scalpel, dan instrumen atau peralatan lain yang tajam; saat menangani peralatan tajam setelah selesai suatu prosedur; saat membersihkan instrumen kotor; dan saat membuang jarum bekas.Jangan memasang kembali tutup jarum, atau berbuat apa pun terhadap jarum itudengan menggunakan kedua tangan, atau menggunakan teknik apapun yangmengarahkan mata jarum ke arah bagian tubuh manapun, tetapi gunakanlah teknik satu tangan atau peralatan khusus untuk memegang jarum. Jangan melepas jarumbekas dari spuitnya dengan tangan, dan jangan menekuk, mematahkan, atau memanipulasi jarum bekas dengan tangan. Letakkan benda-benda tajam sekali pakaiseperti jarum dan

CONTROLLED

spuit bekas, mata skapel bekas, dan peralatan tajam lainnya dalam wadah yang tahan tusukan yang diletakkan sedekat mungkin, dan sepraktis mungkin di lokasi penggunaan peralatan. Letakkan spuit dan jarum yang dpaat digunakan kembali dalam wadah tahan tusukan untuk dibawa ke area pemrosesan ulang.

K. Kewaspadaan berdasarkan penularan/transmisi *(Transmission-based Precautions)*

Kewaspadaan berdasarkan penularan diperuntukkan bagi pasien yang menunjukkan gejala atau dicurigai terinfeksi atau mengalami kolonisasi dengan kuman yang sangat mudah menular atau sangat pathogen sehingga perlu upaya pencegahan tambahan selain kewaspadaan standar yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran infeksi. Kewaspadaan berbasis transmisi harus dilaksanakan sebagai tambahan kewaspadaan standar bila penyakit menular selain melalui darah.

Tiga jenis kewaspadaan berdasarkan penularan adalah sebagai berikut :

a) Kewaspadaan penularan melalui kontak

Kewaspadaan ini bertujuan untuk menurunkan risiko timbulnya *Healthcare Associated Infections* (HAIs), terutama risiko transmisi mikroba yang secara epidemiologi diakibatkan oleh kontak langsung atau tidak langsung. Kewaspadaan ini untuk mengurangi risiko transmisi organisme patogen melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kontak langsung meliputi kontak dengan permukaan kulit yang terbuka dengan kulit terinfeksi atau kolonisasi. Misalnya pada saat petugas membalikkan tubuh pasien, memandikan, membantu pasien bergerak, mengganti perban, merawat oral pasien Herpes Simplex Virus (HSV) tanpa sarung tangan. Transmisi kontak tidak langsung adalah kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi yang ditransmisikan melalui tangan petugas yang belum dicuci atau benda mati dilingkungan pasien, misalnya instrumen, jarum, kasa, mainan anak, dan sarung tangan yang tidak diganti. Petugas harus

CONTROLLED

menahan diri untuk tidak menyentuh mata, hidung, mulut saat masih memakai sarung tangan terkontaminasi/tanpa sarung tangan.

a. Penempatan Pasien

Tempatkan pasien di kamar tersendiri. Bila tidak tersedia kamar tersendiri, tempatkan pasien dalam kamar bersama dengan pasien yang terinfeksi aktif dengan mikroorganisme yang sama tetapi tidak boleh dengan pasien denganinfeksi yang berbeda. Bila tidak tersedia kamar tersendiri dan penggabungan dengan pasien lain tidak diinginkan, pertimbangan sifat epidemiologis mikroorganisme dan populasi pasien saat menempatkan pasien. Disarankan untuk berkonsultasi dengan petugas pengendalian infeksi sebelum menempatkan pasien. Hindari menyentuh permukaan lingkungan lainyang tidak berhubungan dengan perawatan pasien sebelum melakukan aktivitas kebersihan tangan (*hand hygiene*).

b. Sarung tangan dan kebersihan tangan

Selama merawat pasien, ganti sarung tangan setelah menyentuh bahan-bahan terinfeksi yang kira-kira mengandung mikroorganisme dengan konsentrasi tinggi (faeces dan drainase luka). Lepas sarung tangan sebelum meningggalkan lingkungan pasien dan segera membersihkan tangan dan jangan menyentuh permukaan lingkungan yang mungkin terkontaminasi atau barang-barang dalam kamar pasien untuk mencegah perpindahan mikroorganisme ke pasien lain atau lingkungan. Petugas gizi harus membersihkan tangan dahulu setelah menangani peralatan makan pasien.

c. Gaun Pelindung

Sebagai tambahan dari pemakaian gaun yang digariskan dalam Standar Precautions, pakailah gaun (bersih dan tidak perlu steril) saat memasuki kamar pasien bila kira-kira pakaian anda akan bersentuhan dengan pasien, permukaan lingkungan, atau barang-barang dalam kamar pasien, atau bila pasien menderita inkotinensia atau diare, ileostomi, kolostomi, atau drainase luka yang tidak tertutup perban. Lepas gaun sebelum meninggalkan

CONTROLLED

lingkungan pasien. Setelah melepas gaun, pastikan pakaian tidak menyentuh permukaan lingkungan yang mungkin terkontaminasi, untuk mencegah perpindahan mikroorganisme ke pasien lain atau lingkungan.

d. Pemindahan Pasien

Batasi pemindahan dan transportasi pasien dari kamar yang khusus tersedia untuknya hanya untuk hal yang sangat penting saja. Bila memang dibutuhkan pemindahan dan transportasi, pastikan kewaspadaan tetap terjaga untuk meminimalkan kemungkinan penyebaran mikroorganisme ke pasien lain dan kontaminasi permukaan lingkungan dan peralatan.

e. Peralatan Perawatan Pasien

Bila memungkinkan, khususnya penggunaan peralatan non-kritikal hanya untuk satu pasien saja (atau digunakan bersama dengan pasien yang terinfeksi atau terkolonisasi dengan pathogen yang sama yang membutuhkan kewaspadaan) untuk mencegah penggunaan bersama dengan pasien lain. Bila penggunaan bersama tidak dapat dihindari, maka bersihkan dan desinfeksi peralatan tersebut sebelum digunakan oleh pasien lain. Usahakan agar alat perawatan pasien, peralatan di sekitar tempat tidur pasien dan permukaan lain yang sering tersentuh dibersihkan setiap hari. Linen terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning (pastikan tidak bocor) dan diikat serta diberi label infeksius.

CONTROLLED

L. Kewaspadaan penularan melalui percikan (droplet)

Transmisi droplet terjadi ketika partikel droplet berukuran > 5 µm yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, muntah, bicara, selama prosedur suction, bronkhoskopi, melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak < 2 m dan mengenai mukosa atau konjungtiva, untuk itu dibutuhkan APD atau masker yang memadai, bila memungkinkan dengan masker 4 lapis atau yang mengandung pembunuh kuman(germ

decontaminator). Jenis transmisi percikan ini dapat terjadi pada kasus antara lain *common cold*, respiratory syncitial virus (RSV), Adenovirus, H5N1, H1N1, Covid-19.

l) Penempatan Pasien

Tempatkan pasien di kamar tersendiri. Bila tidak tersedia, tempatkan pasien dalam kamar bersama dengan pasien yang terinfeksi aktif dengan mikroorganisme yang sama tetapi tidak boleh dengan pasien dengan infeksi yang berbeda (metode ***cohort***). Bila tidak tersedia kamar tersendiri dan tidak ingin menggabungkan dengan pasien lain, maka pisahkanlah dengan jarak sedikitnya 1 meter dengan pasien lainnya dan pengunjung. Khusus untuk covid-19 jarak tempat tidur minimal adalah 1,5 meter / 2,4 meter. Tidak dibutuhkan penanganan udara dan ventilasi yang khusus, dan pintu boleh tetap dibuka.

m) Masker

Sebagai tambahan *standard precautions*, gunakan masker bila bekerja dalam jarak kurang dari 1 m dari pasien. Akan lebih praktis jika memakai masker diharuskan sejak seseorang memasuki ruangan pasien. Pasien hanya diperbolehkan meninggalkan ruangan hanya jika sangat perlu, dan harus memakai masker.

n) Pemindahan pasien

Batasi pemindahan dan transportasi pasien dari kamar yang khusus tersedia untuknya hanya untuk hal yang sangat penting saja. Bila memang dibutuhkan pemindahan dan transportasi, hindari penyebaran droplet dengan memakaikan masker bedah pada pasien, bila memungkinkan.

11. Kewaspadaan penularan melalui udara *(airborne)*

Transmisi melalui udara secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan partikel nuklei yang berdiameter 1-5 µm (<5 µm) yang mengandung mikroba penyebab infeksi. Mikroba tersebut akan terbawa aliran udara >2 m dari sumber, dapat terhirup oleh individu rentan di ruang yang sama atau yang jauh dari sumber

CONTROLLED

mikroba. Penting mengupayakan pertukaran udara >12 x/jam (12 *Air Changes per Hour*/ACH). Orang termasuk petugas Rumah Sakit, yang rentan terhadap penyakit campak (measles) dan cacar air (varicella), covid-19 dilarang masuk ke ruangan pasien dengan penyakit tersebut.

a) Penempatan Pasien

Tempatkan pasien di kamar tersendiri yang memiliki syarat sebagai berikut:

1) Bertekanan udara negatif dibandingkan dengan ruangan sekitarnya.
2) Memiliki saluran pengeluaran udara ke lingkungan yang memadai atau memiliki sistem penyaringan udara yang efisien sebelum udara di sirkulasi ke ruangan lain.
3) Penempatan pasien TB yang belum pernah mendapatkan terapi OAT, harus dipisahkan dari pasien lain, sedangkan pasien TB yang telah mendapat terapi OAT secara efektif berdasarkan analisis resiko tidak berpotensi menularkan TB baru dapat dikumpulkan dengan pasien lain.
4) Pengaturan penempatan posisi pemeriksa, pasien dan ventilasi mekanis di dalam suatu ruangan dengan memperhatikan arah suplai udara bersih yang masuk dan keluar.
5) Pintu harus selalu tertutup dan pasien tersebut ada di dalamnya. Bila tidak tersedia kamar tersendiri, tempatkan pasien bersama dengan pasien lain yangterinfeksi aktif dengan mikroorganisme yang sama, kecuali bila ada rekomendasi lain. Dilarang menempatkannya dengan pasien dengan jenis infeksi lain. Bila tidak tersedia kamar tersendiri dan perawatan gabung tidak diinginkan, konsultasikan dengan petugas pengendalian infeksi sebelum menempatkan pasien.
6) Tekanan negatif termonitor
7) Peringatan tentang cara transmisi infeksi dan penggunaan APD pada pasien, petugas dan pengunjung penting dicantumkan di pintu ruangan rawat pasien sesuai kewaspadaan transmisinya. Berikan tanda gambar masker di depan pintu sebagai tanda pasien infeksi yang dapat menular melalui*Airborne*/droplet.

CONTROLLED

8) Ruang rawat pasien TB/MDR TB sebaiknya menggunakan ruangan bertekanan negatif. Untuk RS yang belum mampu menyediakan ruang tersebut, harus memiliki ruang dengan ventilasi yang memadai, minimal terjadi pertukaran udara 12x/jam.

b) Perlindungan Pernafasan (Masker)

Gunakan masker bila memasuki kamar pasien yang diketahui atau dicurigai menderita tuberculosis paru-paru. Orang-orang yang sensitif dilarang memasuki kamar pasien yang diketahui atau dicurigai menderita campak (rubela) atau varicella.

c) Pemindahan Pasien

Batasi pemindahan dan transportasi pasien dari kamar yang khusus tersedia untuknya hanya untuk hal yang sangat penting saja. Bila memang dibutuhkan pemindahan dan transportasi, hindari penyebaran droplet dengan memakaikan masker bedah pada pasien.

M. Pemulangan Pasien

1. Upaya pencegahan infeksi harus tetap dilakukan sampai batas waktu masa penularan.
2. Bila dipulangkan sebelum masa isolasi berakhir, pasien yang dicurigai terkena penyakit menular melalui udara/*airborne* harus diisolasi di dalam rumah selama pasien tersebut mengalami gejala sampai batas waktu penularan atau sampai diagnosis alternative dibuat atau hasil uji diagnosa menunjukkan bahwa pasien tidak terinfeksi dengan penyakit tersebut. Keluarga harus diajarkan cara menjaga kebersihan diri, pencegahan dan pengendalian infeksi serta perlindungan diri.
3. Sebelum pemulangan pasien, pasien dan keluarganya harus diajarkan tentang tindakan pencegahan yang perlu dilakukan, sesuai dengan cara penularan penyakit menular yang diderita pasien.
4. Pembersihan dan desinfeksi ruangan yang benar perlu dilakukan setelah pemulangan pasien.

CONTROLLED

N. Perawatan Kasus Meninggal untuk Pasien SARS (Flu Burung, Flu Babi (Emerging Case), Influenza A, MERS-CoV, Covid-19, ISPA lain yang berpotensi mejadi wabah.

1. Petugas menjalankan kewaspadaan standar etika menangani pasien yang meninggalakibat penyakit menular.
2. APD lengkap digunakan oleh petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebutmeninggal dalam masa penularan.
3. Jenazah terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembussebelum dipindahkan ke kamar jenazah.
4. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
5. Jenazah segera dipindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.
6. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan dengan memberi jarak dan memakai APD masker.
7. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas adat istiadat dan budaya harus diperhatikan etika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
8. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
9. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
10. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.
11. Jenazah berada di kamar jenazah tidak lebih dari 4 jam.

O. Pembersihan Peralatan dan kamar Pasien

Pembersihan kamar dilakukan saat pasien pulang atau saat penggunaan kamar isolasi tidak diperlukan lagi. Pembersihan kamar dilakukan menggunakan cairan clorin 0.5%. Petugas kebersihan bertanggung jawab untuk membersihkan area lingkungan kamar sedangkan perawat bertanggung jawab membersihkan alat-alat medis. Gorden harus dilepaskan dan dikirim ke laundry sebagai linen

CONTROLLED

infeksius, sebelum proses pembersihan dilakukan. Semua area dibersihkan dengan menggunakan lap khusus infeksius, perhatikan pembersihan pada area permukaan, area yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, tombol *nurse call*, tombol lampu, area toilet, tempat tidur, mattress, meja pasien, dll.

P. Outbreaks/ Kejadian luar biasa

Apabila terjadi *outbreaks* yaitu peningkatan arus pasien dengan penyakit menular dan ruang isolasi yang diperlukan penuh maka beberapa orang pasien yang terinfeksi atau terkolonisasi dengan organisme penyakit yang sama tsb, dapat ditempatkan di ruangan yang sama dan dirawat oleh perawat yang dibatasi merawat pasien tsb untuk menghindari resiko transmisi silang mikroorganisme. Hal ini dikenal sebagai metode kohorting. Selain itu, penting agar ruangan tersebut memiliki pintu yang bisa ditutupi untuk memisahkan pasien isolasi dari pasien lainnya. Apabila metode kohort telah dilakukan namun masih terdapat peningkatan arus pasien, maka dibuat Temporary Isolation Negatif Pressure.

Q. Keselamatan Kerja

Petugas kesehatan yang merawat pasien penyakit *immunocompromised* harus sudah mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.

Petugas tersebut juga dilakukan pemeriksaan berkala setiap setahun sekali untukmemantau kesehatan petugas.

CONTROLLED

KEWASPADAAN BERBASIS TRANSMISI

Transimisi	Kontak	Droplet	*Airborne*
Penempatan pasien	1. Tempatkan: • Di ruang rawat terpisah atau *cohorting* atau dipertimbangkan bersama Komite PPI • Tempat tidur dengan jarak ≥1 meter	1. Tempatkan: • Di ruang rawat terpisah atau *cohorting* atau dipertimbangkan bersama Komite PPI • Tempat tidur dengan jarak ≥1 meter 2. Cegah terjadinya kontaminasi	1. Tempatkan: • Di ruang rawat terpisah atau *cohorting* atau dipertimbangkan bersama Komite PPI • Tempat tidur dengan jarak ≥ 1 meter. Khusus covid-19 minimal 1,5 meter atau 2,4 meter • Ruang bertekanan negatif atau ruang dengan pertukaran udara 12 x.jam 2. Cegah terjadinya kontaminasi

CONTROLLED

Transimisi	Kontak	Droplet	*Airborne*
Transport/transferpasien	Batasi gerak	• Batasi gerak. Gunakan maskeruntuk pasien ketika transfer. • Edukasi etika batuk	• Batasi gerak. Gunakan maskeruntuk pasien ketika transfer. • Edukasi etika batuk
APD	• Kebersihan tangansebelum menggunakan APD • Sarung tangan dangaun bagi petugassaat masuk ke ruang pasien • Ganti sarung tangan setelah kontak dengan bahan infeksius (feses, cairan tubuh, darah) • Gaun dipakai saat masuk ruangan untuk melindungi kontak dengna pasien, permukaan lingkungan, barang di ruang pasien, cairan	• Kebersihan tangansebelum menggunakan APD • Sarung tangan, gaun dan masker dipakai bekerja dalam radius 1-2 meter terhadap pasien saat kontakerat. • Gaun dan apron sama seperti transmisi kontak	• Kebersihan tangansebelum menggunakan APD • Masker bedah untuk pasien dan respirator partikulat (N95) untuk petugas saatmasuk ke ruang pasien. • Orang yang rentantidak boleh masukke ruang pasien yang diketahui atau susperk campak, cacar air • Bila masuk ataumelakukan tindakan dengan kemungkinan timbul aerosol

CONTROLLED

	diare pasien, ileostomy, colostomy, luka terbuka. • Lepaskan gaun sebelum keluar ruangan • Apron untuk mengurangi penetrasi cairan. Bila memungkinkan peralatan dipakaiuntuk 1 pasien atau pasien lain dengan mikroba yang sama		maka petugas harus mengenakan Masker N95

CONTROLLED

Transimisi	Kontak	Droplet	*Airborne*
Peralatan untuk perawatan pasien dan lingkung	• Perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien pulang • Dapat dipakai Na Hipoklorit 0,5 % bilas dengan air atau dengan H2O2 0,5 – 1,4%	• Ruang rawat pasien dengan transmisi droplet tidak perlu penanganan udara secara khusus karena mikroba tidak bergerak jauh. • Perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien pulang	Terminal dekontaminasi dilakukan secara dekontaminasi permukaan menggunakan H2)2 0,5 – 1,4 % dengan lama kontak 30 detik – 1 menit (baktericidal, virucidal) atau lama kontak 5 menit bila dengan tujuan mikobakterisidal atau dry mist dengan
		• Dapat dipakai Na Hipoklorit 0,5 % bilas dengan air atau dengan H2O2 0,5 – 1,4%	H2O2 5 % dikombinasikan dengna Ag dengan lama kontak 55 menit untuk luas ruangan 0,135 m3.

CONTROLLED

Daftar Penyakit Isolasi Bertekanan Negatif serta Tata laksananya				
No	**Penyakit**	**Sumber Infeksi**	**Cara Penularan**	**Pencegahan**
1.	**Meningitis** - Haemophilus Influenza - Neissera Meningitis - Streptococcus Pneumonia	- Saluran Pernapasan Atas - Sekresi	- Melalui *Airborne* - Kontak langsung yang lama	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol
2.	**MUMPS/Parotitis**	- Sekresi saluran pernapasan	- Melalui *Airborne*	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol
3.	**Pertusis** - Anak-anak batuk lebih dari 100 hari	- Sekresi saluran pernapasan air/ liur	- Melalui *Airborne*	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol

CONTROLLED

Daftar Penyakit Isolasi Bertekanan Negatif serta Tata laksananya				
No	**Penyakit**	**Sumber Infeksi**	**Cara Penularan**	**Pencegahan**
4.	**Morbili / Campak**	- Sekresi saluran pernapasan - Sekret Kontak	- Melalui *Airborne*	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol
5.	**Tuberkulosis** Bila tidak pernah mendapat terapi TBCatau sudah pernah mendapat terapi TB kurang dari 2 minggu	- Sekresi saluran pernapasan	- Melalui *Airborne* / droplet	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol
6.	**Varicella / Cacar Air**	- Sekresi bullae	- Melalui *Airborne* dan sekresi	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Sarung tanganjika kontak - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol

CONTROLLED

7.	**Herpes Zoster**	- Sekresi bullae	- Melalui *Airborne* dan sekresi	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Sarung tanganjika kontak - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol

CONTROLLED

Daftar Penyakit Isolasi Bertekanan Negatif serta Tata laksananya				
No	**Penyakit**	**Sumber Infeksi**	**Cara Penularan**	**Pencegahan**
8	**Covid-19**	Salauran pernafasan	Kontak , Droplet dan *Airborne*	- Isolasi Tekanan Negatif - Pakai Sarung tangan dan gaun jika kontak - Pakai Masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol
9	**SARS** - Flu Burung - Flu Babi (Emerging Case) - Influenza A - MERS CoV - ISPA lain yg berpotensi menjadiwabah baru.	- Sekresi saluran pernapasan	- Melalui udara	Dirujuk - Pakai masker bedah - Respirator (masker N95) saat melakukan tindakan Aerosol - Pakai goggle - Pakai jas/ apron - Pakai sarung tangan

CONTROLLED

BAB V
DOKUMENTASI

1. Formulir Catatan Informasi dan Edukasi
2. Ceklist Pembersihan Ruang Isolasi
3. Formulir Audit Kamar Isolasi

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

(dr. Agus Marvianto)

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA

	Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh	Disetujui oleh :
Nama	dr. Ignatius Pramudya W, Sp.OG	dr. Eufracia Ratna Hany Perdani	dr. Agus Marvianto
Jabatan	Ketua Komite PPI	Sub Komite Mutu	Direktur Rumah Sakit
Tanda tangan			

CONTROLLED

PRIMAYA
HOSPITAL
BHAKTI WARA

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA
Jl. Solihin GP No. 180, Kel. Gajah Mada,
Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang,
Kepulauan Bangka Belitung 33139
Telp. +62 717 422 605

www.primayahospital.com primayahospital primayahospital

Tangerang | Bekasi Barat | Bekasi Timur | Bekasi Utara | Evasari | Cikini | Karawang
Makassar | Sorowako | Palangkaraya | Pasar Kemis | Sukabumi | Pangkal Pinang | Semarang

---

Primaya Hospital yang kualitas dan standar keselamatan pasiennya sudah terakreditasi oleh Joint Commission International (JCI)